

NOTULEN

HARI / TANGGAL : SENIN/16 MARET 2026
PUKUL : 13.00 WIB
AGENDA RAPAT : HASIL SO FARMASI FEB 2026

PEMIMPIN RAPAT: dr. SADI HARIONO, M.MRS
NOTULIS : AVIVA SENJA, S.AK
TEMPAT : ZOOM MEETING

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Format PPT	Perbaikan format PPT	Mencamtumkan total obat secara keseluruhan Ditambahkan kata “selisih” pada grafik perbandingan selisih Ketertiban dalam penulisan Pada slide selisih depo, ditambahkan jumlah dan jumlah selisih bisa di <i>bold</i> Analisa selisih bisa dirincikan di unit, tidak dituliskan secara global selisih positif /negative Pada grafik data selsish dapat ditambahkan Analisa, jika hasil audit dapat menurunkan jumlah selisih, maka lakukan setiap hari	Farmasi, Kabid dan Manajemen RS

2.	Perlakuan Selisih Hasil SO	Kenapa ada selisih meskipun jumlah kecil?	Pelaksanaan monitoring, audit secara berkala, supervisi	Farmasi, Kabid dan Manajemen RS
3.	Kwitansi ekclaim : terdapat jasa pasang kateter tetapi kateter tdk terinput dan sebaliknya	Di farmasi tdk muncul jasa tindakan (sering kecolongan)	Kains Farmasi dapat membuka ERM dan dapat dilakukan diskusi terkait kateter dan jasanya. Koordinasi farmasi dengan unit terkait stok minimal, penggunaan barang tsb.	Farmasi, Kabid dan Manajemen RS
4.	Perbedaan permintaan awal BMHP dan resep	Perawat poli input BMHP secara manual	Programmer dapat memunculkan stock diunit pada SIMRS, jika ada ketidaksesuaian (kelebihan) dapat dilakukan retur. Dengan recana alur : Permintaan barang dr poli > stock masuk poli > pemakaian obat/bmph > terdapat selisih (kurang/lebih) > selisih menjadi tanggung jawab poli > retur oleh poli	Programmer PT, Farmasi, Kabid dan Manajemen RS
5.	Barang Near ED	Alkes ED lewat 6 bulan masih bisa digunakan Monitoring barang ED hanya terjamin pada Gudang Pada depo tidak terjamin karena ketikan <i>moving</i> obat ED nya tercampur (karena depo ketika mengeluarkan barang tidak ada tanggal ED) sedangkan sistem memproses barang keluar sesuai dengan ED paling dekat,	Untuk selanjutnya regulasi alkes dapat disesuaikan dengan sop retur obat near ED. Acuan Gudang ED min 2 tahun (telah berjalan) Kerjasama antar Gudang dan Unit terkait pengeluaran barang farmasi, barang lama dapat dilakukan pengeluaran lebih dulu Buat kebijakan dan tabel berapa batas minimal ED barang diterima, <i>sounding</i> DPJP terkait peresepan, batas umur barang dikembalikan/di retur.	Programmer PT, Farmasi, Kabid dan Manajemen RS

			Semakin tinggi retur semakin tidak bagus > mutu, menunjukkan ketidak tanggungjawab kita dalam order obat Apakah programmer perlu menambahkan menu ED pada pengeluaran obat?	
6.	Pengadaan Barang	Terkait jumlah order barang, minimal stock untuk order, dan rata – rata jumlah pemakaian	Jumlah pembelian dapat didiskusikan terlebih dahulu dengan melihat rata – rata jumlah pemakaian dan sisa barang. Jangan semata – mata menambah barang selagi harga murah. Kandungan obat paten yang ada pada obat generiknya, dapat dilakukan evaluasi terkait penggunaannya (obat paten dapat ditutup). Jika ada order barang sejenis, master barang dapat dinonaktifkan terlebih dahulu, agar tidak ada akses untuk order lagi (otoritas aktif-nonaktif master barang ada pada Direktur PT). Jika ada double merk karena kekosongan pabrik, barang lama dihabiskan terlebih dahulu. Jika terdapat barang <i>slow moving</i>, yang order diminta untuk membantu persepan atau bisa di lakukan distribusi ke Mutiara sehat. Penamaan barang diperhatikan agar tidak salah order obat terutama LASA	Programmer PT, Farmasi, Kabid dan Manajemen RS

7.	Sistem SO	Terdapat ketidaksesuaian anatara fisik dan sistem	Tidak ada akar masalah terkait ketidaktelitian dan kesalahan, yang ada tanggung jawab dari farmasi terkait hal tersebut Terkait ketidaktelitian kesalahan bisa dicantumkan nama atau pj nya Jika ada fisik barang tetapi tidak ada pada rak system, dapat berkoordinasi dengan pengadaan PT terkait penambahan rak pada system Untuk selanjutnya PT dapat menginformasikan jumlah pembelian dan penjualan obat kepada masing2 – masing RS sebelum so, agar dapat menjadi bahan diskusi pada saat pelaporan hasil SO Obat <i>sharing dose</i> masih perlu dibenahi (buat daftar barang sharing dose) Laporan terkait obat- obat narkotika, psikotropika, dan obat yang diawasi pengedarannya. Laporan terkait jumlah macam merk dagang, jumlah principle, pembelian obat baru bulan ini, obat yang sudah tidak dipakai bulan ini, dengan tujuan evaluasi penggunaan obat.	Programmer PT, Pengadaan PT, Farmasi, Kabid dan Manajemen RS
----	-----------	--	--	---

			Target tidak ada penggantian dan selisih, <i>double check</i> wajib dilakukan (dituliskan pj nya, agar terdeteksi apakah ada permasalahan). PT Membuatkan system pengeluaran obat ketika so berjalan.	
--	--	--	---	--

Pemimpin Rapat

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

dr. Sadi Hariono, M.MRS

Malang, 16 Maret 2026

Notulis

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

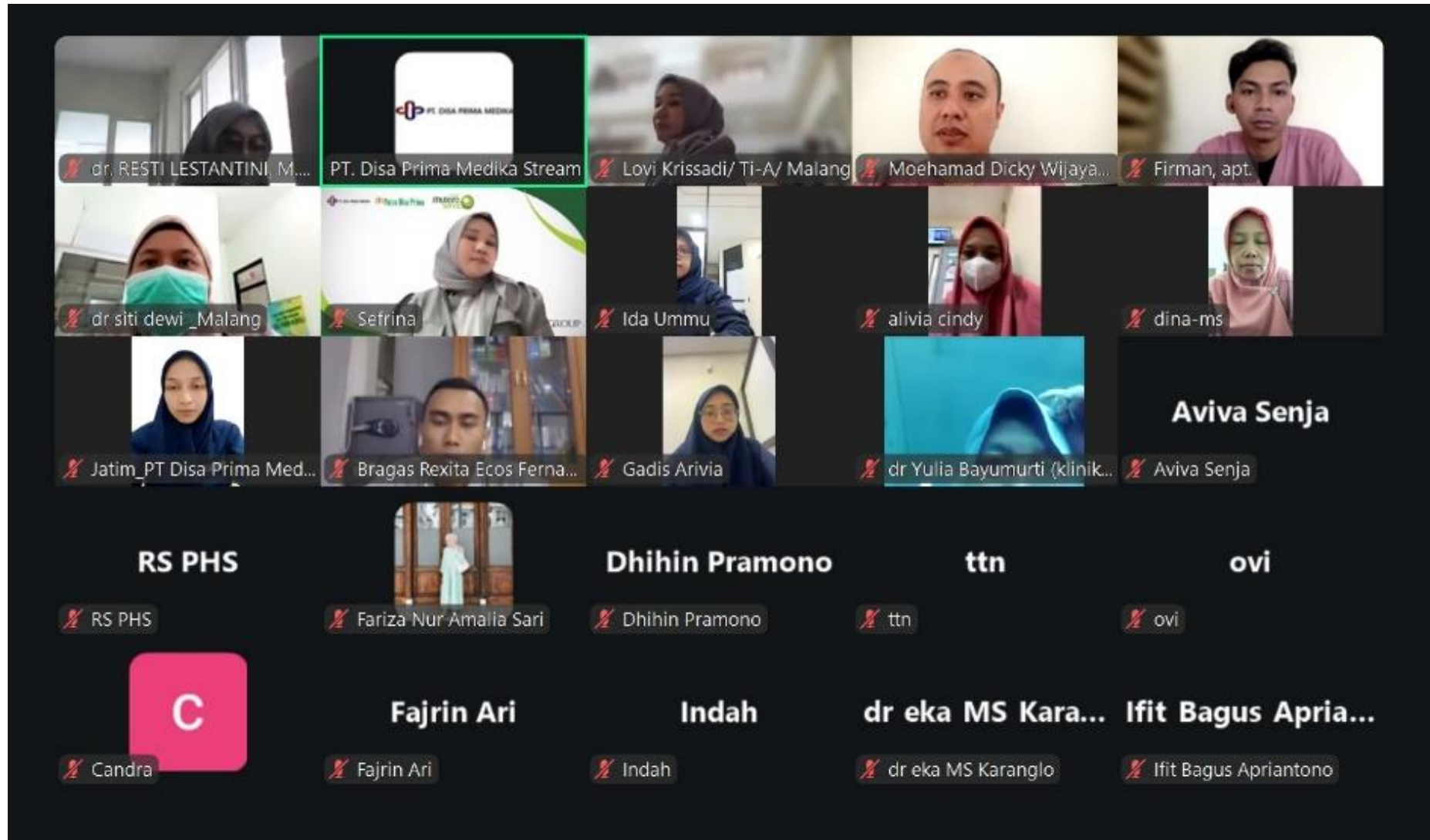
Aviva Senja Pangesti, S. Ak

Mengetahui,
Direktur PT Disa Prima Medika



dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

DOKUMENTASI



The screenshot displays a Zoom meeting interface with 20 participants arranged in a grid. The participants are as follows:

- Row 1:** dr. RESTI LESTANTINI, M..., PT. Disa Prima Medika Stream, Lovi Krissadi/ Ti-A/ Malang, Moehamad Dicky Wijaya..., Firman, apt.
- Row 2:** dr siti dewi _Malang, Setrina, Ida Ummu, alivia cindy, dina-ms
- Row 3:** Jatim_PT Disa Prima Med..., Bragas Rexita Ecos Ferna..., Gadis Arivia, dr Yulia Bayumurti (klinik..., Aviva Senja
- Row 4:** RS PHS, Fariza Nur Amalia Sari, Dhihin Pramono, ttn, ovi
- Row 5:** Candra, Fajrin Ari, Indah, dr eka MS Kara..., Ifit Bagus Apria...